VIH — 50 flashcards

Questions de rappel actif. Les réponses et explications sont reprises de la banque canonique du cours.

CARTE 01 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Qu'est-ce que le VIH ?

VERSO — Le virus de l'immunodéficience humaine est un rétrovirus. Il a besoin d'une cellule hôte pour se multiplier ; son ADN peut s'intégrer au génome de la cellule.

POUR COMPRENDRE — Le virus de l'immunodéficience humaine est un rétrovirus. Il a besoin d'une cellule hôte pour se multiplier ; son ADN peut s'intégrer au génome de la cellule.

CARTE 02 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Pourquoi les antirétroviraux ne guérissent-ils pas habituellement le VIH ?

VERSO — Ils bloquent la réplication, mais l'ADN viral intégré peut persister dans des réservoirs. Une charge virale indétectable n'équivaut pas à une éradication.

POUR COMPRENDRE — Ils bloquent la réplication, mais l'ADN viral intégré peut persister dans des réservoirs. Une charge virale indétectable n'équivaut pas à une éradication.

CARTE 03 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Qu'est-ce qu'un lymphocyte T CD4 ?

VERSO — C'est un globule blanc qui coordonne les réponses immunitaires : un « chef d'orchestre » de l'immunité. Il n'est ni une hormone ni un anticorps.

POUR COMPRENDRE — C'est un globule blanc qui coordonne les réponses immunitaires : un « chef d'orchestre » de l'immunité. Il n'est ni une hormone ni un anticorps.

CARTE 04 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Pourquoi le VIH expose-t-il aux infections opportunistes ?

VERSO — Il cible et détruit progressivement les lymphocytes T CD4. Les défenses immunitaires diminuent et certaines infections deviennent plus probables.

POUR COMPRENDRE — Il cible et détruit progressivement les lymphocytes T CD4. Les défenses immunitaires diminuent et certaines infections deviennent plus probables.

CARTE 05 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Charge virale et nombre de CD4 : quelle différence ?

VERSO — La charge virale mesure l'ARN du VIH circulant ; le nombre de CD4 renseigne sur l'état immunitaire. Ce sont deux marqueurs complémentaires.

POUR COMPRENDRE — La charge virale mesure l'ARN du VIH circulant ; le nombre de CD4 renseigne sur l'état immunitaire. Ce sont deux marqueurs complémentaires.

CARTE 06 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Qu'appelle-t-on « ADN proviral » ?

VERSO — L'ADN du VIH intégré dans le génome de cellules infectées. Il participe à la persistance du virus et ne se confond pas avec l'ARN viral circulant.

POUR COMPRENDRE — L'ADN du VIH intégré dans le génome de cellules infectées. Il participe à la persistance du virus et ne se confond pas avec l'ARN viral circulant.

CARTE 07 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Que signifie le repère de 200 CD4/mm³ ?

VERSO — Au-dessous d'environ 200 CD4/mm³, le risque d'infections opportunistes augmente fortement. Ce seuil ne suffit pas, à lui seul, à définir automatiquement le stade sida.

POUR COMPRENDRE — Au-dessous d'environ 200 CD4/mm³, le risque d'infections opportunistes augmente fortement. Ce seuil ne suffit pas, à lui seul, à définir automatiquement le stade sida.

CARTE 08 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Quelle différence entre être séropositif au VIH et avoir le sida ?

VERSO — On peut vivre avec le VIH sans être au stade sida. Le sida correspond à un stade avancé défini par certains critères, notamment des maladies opportunistes caractéristiques.

POUR COMPRENDRE — On peut vivre avec le VIH sans être au stade sida. Le sida correspond à un stade avancé défini par certains critères, notamment des maladies opportunistes caractéristiques.

CARTE 09 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Une infection opportuniste signifie-t-elle toujours « sida » ?

VERSO — Non. Elle peut survenir chez une personne immunodéprimée pour une autre raison, par exemple après une greffe. Le diagnostic de sida est lié à l'infection par le VIH.

POUR COMPRENDRE — Non. Elle peut survenir chez une personne immunodéprimée pour une autre raison, par exemple après une greffe. Le diagnostic de sida est lié à l'infection par le VIH.

CARTE 10 · VIH, CD4 et sida

RECTO — Que signifie le sigle PVVIH et pourquoi cette expression est-elle pertinente dans la relation de soin ?

VERSO — Il signifie « personne vivant avec le VIH ». Il évite de réduire la personne à son infection et soutient une relation de soin sans stigmatisation.

POUR COMPRENDRE — Il signifie « personne vivant avec le VIH ». Il évite de réduire la personne à son infection et soutient une relation de soin sans stigmatisation.

CARTE 11 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Quelles sont les principales voies de transmission du VIH ?

VERSO — La transmission est surtout sexuelle en France. La transmission sanguine et la transmission parent-enfant sont aussi possibles selon les situations.

POUR COMPRENDRE — La transmission est surtout sexuelle en France. La transmission sanguine et la transmission parent-enfant sont aussi possibles selon les situations.

CARTE 12 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Le contact ordinaire avec une PVVIH transmet-il le VIH ?

VERSO — Non. Un examen clinique courant ou le contact social n'est pas une exposition au VIH. Les soins reposent sur les précautions standard pour toutes les personnes.

POUR COMPRENDRE — Non. Un examen clinique courant ou le contact social n'est pas une exposition au VIH. Les soins reposent sur les précautions standard pour toutes les personnes.

CARTE 13 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Qu'est-ce que le principe « I = I » ?

VERSO — « Indétectable = intransmissible » : sous traitement efficace, avec suppression virale durablement contrôlée, le VIH n'est pas transmis lors des rapports sexuels.

POUR COMPRENDRE — « Indétectable = intransmissible » : sous traitement efficace, avec suppression virale durablement contrôlée, le VIH n'est pas transmis lors des rapports sexuels.

CARTE 14 · Transmission et évolution clinique

RECTO — I = I dispense-t-il de prévenir les autres IST ?

VERSO — Non. Le principe porte sur la transmission sexuelle du VIH sous suppression virale durable ; il ne protège pas des autres IST ni ne remplace les précautions standard.

POUR COMPRENDRE — Non. Le principe porte sur la transmission sexuelle du VIH sous suppression virale durable ; il ne protège pas des autres IST ni ne remplace les précautions standard.

CARTE 15 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Quand survient généralement la primo-infection VIH ?

VERSO — La séance situe ses manifestations possibles environ 2 à 6 semaines après la contamination. Elle peut rester asymptomatique ou ressembler à une grippe.

POUR COMPRENDRE — La séance situe ses manifestations possibles environ 2 à 6 semaines après la contamination. Elle peut rester asymptomatique ou ressembler à une grippe.

CARTE 16 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Quels signes doivent faire évoquer une primo-infection ?

VERSO — Fièvre, céphalées, pharyngite, éruption, ganglions ; parfois anomalies biologiques. Ces signes sont non spécifiques et ne permettent pas seuls de diagnostiquer le VIH.

POUR COMPRENDRE — Fièvre, céphalées, pharyngite, éruption, ganglions ; parfois anomalies biologiques. Ces signes sont non spécifiques et ne permettent pas seuls de diagnostiquer le VIH.

CARTE 17 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Qu'est-ce que la latence clinique du VIH ?

VERSO — Une période parfois longue avec peu ou pas de symptômes. Le virus demeure présent et peut continuer à se répliquer : « asymptomatique » ne signifie pas « indétectable ».

POUR COMPRENDRE — Une période parfois longue avec peu ou pas de symptômes. Le virus demeure présent et peut continuer à se répliquer : « asymptomatique » ne signifie pas « indétectable ».

CARTE 18 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Comment évolue le VIH sans traitement ?

VERSO — Après la primo-infection et une période de latence possible, les CD4 diminuent progressivement et les complications immunitaires peuvent apparaître.

POUR COMPRENDRE — Après la primo-infection et une période de latence possible, les CD4 diminuent progressivement et les complications immunitaires peuvent apparaître.

CARTE 19 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Pourquoi une personne traitée peut-elle mener une vie proche de la normale ?

VERSO — Le traitement contrôle la réplication, permet généralement la remontée des CD4 et réduit le risque de complications. L'observance et le suivi restent essentiels.

POUR COMPRENDRE — Le traitement contrôle la réplication, permet généralement la remontée des CD4 et réduit le risque de complications. L'observance et le suivi restent essentiels.

CARTE 20 · Transmission et évolution clinique

RECTO — Quelles complications autres qu'infectieuses sont évoquées ?

VERSO — Un risque accru de certains cancers et de maladies cardiovasculaires, favorisé notamment par l'inflammation liée à une infection non contrôlée.

POUR COMPRENDRE — Un risque accru de certains cancers et de maladies cardiovasculaires, favorisé notamment par l'inflammation liée à une infection non contrôlée.

CARTE 21 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Qu'appelle-t-on « infection opportuniste » ?

VERSO — Une infection favorisée par un affaiblissement des défenses immunitaires. Chez une PVVIH très immunodéprimée, certaines infections peuvent révéler un stade sida.

POUR COMPRENDRE — Une infection favorisée par un affaiblissement des défenses immunitaires. Chez une PVVIH très immunodéprimée, certaines infections peuvent révéler un stade sida.

CARTE 22 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Que provoque la pneumocystose ?

VERSO — Cette infection fongique atteint surtout les poumons et peut entraîner toux, fièvre, dyspnée et détresse respiratoire. Elle peut nécessiter des soins intensifs.

POUR COMPRENDRE — Cette infection fongique atteint surtout les poumons et peut entraîner toux, fièvre, dyspnée et détresse respiratoire. Elle peut nécessiter des soins intensifs.

CARTE 23 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Quelle prévention de la pneumocystose est citée ?

VERSO — Une prophylaxie par cotrimoxazole (Bactrim) chez des personnes dont les CD4 sont très bas, notamment sous le repère des 200/mm³, selon la décision médicale.

POUR COMPRENDRE — Une prophylaxie par cotrimoxazole (Bactrim) chez des personnes dont les CD4 sont très bas, notamment sous le repère des 200/mm³, selon la décision médicale.

CARTE 24 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Quels signes peuvent révéler une toxoplasmose cérébrale ?

VERSO — Déficit neurologique focal, hémiplégie ou crise convulsive, parfois tableau évoquant un AVC. L'imagerie peut montrer des lésions intracérébrales.

POUR COMPRENDRE — Déficit neurologique focal, hémiplégie ou crise convulsive, parfois tableau évoquant un AVC. L'imagerie peut montrer des lésions intracérébrales.

CARTE 25 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Quelle atteinte évoque une cryptococcose chez une PVVIH ?

VERSO — Une méningite avec céphalées et fièvre, parfois hypertension intracrânienne. L'enseignante évoque surtout les immunodépressions profondes et des ponctions lombaires répétées.

POUR COMPRENDRE — Une méningite avec céphalées et fièvre, parfois hypertension intracrânienne. L'enseignante évoque surtout les immunodépressions profondes et des ponctions lombaires répétées.

CARTE 26 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Quelles atteintes typiques du CMV sont citées ?

VERSO — Rétinite pouvant menacer la vision et colite avec diarrhées importantes. D'autres atteintes, notamment neurologiques, sont possibles.

POUR COMPRENDRE — Rétinite pouvant menacer la vision et colite avec diarrhées importantes. D'autres atteintes, notamment neurologiques, sont possibles.

CARTE 27 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Quel dépistage faut-il penser à proposer devant une tuberculose ?

VERSO — Un dépistage du VIH. L'enseignante insiste explicitement : rechercher une éventuelle infection VIH chez toute personne atteinte de tuberculose.

POUR COMPRENDRE — Un dépistage du VIH. L'enseignante insiste explicitement : rechercher une éventuelle infection VIH chez toute personne atteinte de tuberculose.

CARTE 28 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Quelles précautions devant une tuberculose pulmonaire contagieuse ?

VERSO — Des précautions « Air », et non simplement « gouttelettes », selon les protocoles de soins. La prévention du risque respiratoire est une priorité.

POUR COMPRENDRE — Des précautions « Air », et non simplement « gouttelettes », selon les protocoles de soins. La prévention du risque respiratoire est une priorité.

CARTE 29 · Infections opportunistes et complications

RECTO — La tuberculose ne survient-elle que lorsque les CD4 sont très bas ?

VERSO — Non. Elle peut apparaître à différents stades de l'infection VIH, y compris avant une immunodépression profonde.

POUR COMPRENDRE — Non. Elle peut apparaître à différents stades de l'infection VIH, y compris avant une immunodépression profonde.

CARTE 30 · Infections opportunistes et complications

RECTO — Quel cancer est associé au virus HHV-8 ?

VERSO — La maladie de Kaposi, illustrée par des nodules cutanés violacés. Sont aussi évoqués les lymphomes et certains cancers liés au papillomavirus.

POUR COMPRENDRE — La maladie de Kaposi, illustrée par des nodules cutanés violacés. Sont aussi évoqués les lymphomes et certains cancers liés au papillomavirus.

CARTE 31 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Quels examens sont évoqués pour dépister le VIH ?

VERSO — La sérologie sanguine et des tests rapides (TROD, autotests). Le choix du test et son interprétation dépendent notamment du contexte d'exposition.

POUR COMPRENDRE — La sérologie sanguine et des tests rapides (TROD, autotests). Le choix du test et son interprétation dépendent notamment du contexte d'exposition.

CARTE 32 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Comment interpréter un autotest VIH réactif ?

VERSO — Un résultat positif ou réactif sur un test rapide doit être confirmé par un examen biologique adapté. Il ne doit pas être présenté seul comme diagnostic définitif.

POUR COMPRENDRE — Un résultat positif ou réactif sur un test rapide doit être confirmé par un examen biologique adapté. Il ne doit pas être présenté seul comme diagnostic définitif.

CARTE 33 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Que suit-on régulièrement chez une PVVIH traitée ?

VERSO — La charge virale, les CD4 et l'état clinique. La séance cite comme objectif de suppression une charge virale inférieure à 50 copies/mL.

POUR COMPRENDRE — La charge virale, les CD4 et l'état clinique. La séance cite comme objectif de suppression une charge virale inférieure à 50 copies/mL.

CARTE 34 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Pourquoi rechercher d'autres IST chez une PVVIH ?

VERSO — Les expositions peuvent concerner plusieurs infections. La séance cite notamment hépatites B et C, syphilis, chlamydia et gonocoque.

POUR COMPRENDRE — Les expositions peuvent concerner plusieurs infections. La séance cite notamment hépatites B et C, syphilis, chlamydia et gonocoque.

CARTE 35 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Quand et pendant combien de temps traiter le VIH ?

VERSO — Débuter les antirétroviraux dès que possible et poursuivre au long cours, en principe à vie. Une interruption peut laisser la réplication reprendre et les CD4 baisser.

POUR COMPRENDRE — Débuter les antirétroviraux dès que possible et poursuivre au long cours, en principe à vie. Une interruption peut laisser la réplication reprendre et les CD4 baisser.

CARTE 36 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — « Trithérapie » signifie-t-il toujours trois comprimés ?

VERSO — Non. Certaines associations contiennent 2 ou 3 molécules dans un seul comprimé quotidien ; des traitements injectables existent aussi dans des indications choisies.

POUR COMPRENDRE — Non. Certaines associations contiennent 2 ou 3 molécules dans un seul comprimé quotidien ; des traitements injectables existent aussi dans des indications choisies.

CARTE 37 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Quels exemples de traitements combinés sont cités ?

VERSO — Biktarvy, Dovato et Delstrigo. Leur composition et leur indication diffèrent : le schéma est individualisé par le prescripteur.

POUR COMPRENDRE — Biktarvy, Dovato et Delstrigo. Leur composition et leur indication diffèrent : le schéma est individualisé par le prescripteur.

CARTE 38 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Une PVVIH contrôlée peut-elle envisager une grossesse spontanée ?

VERSO — Oui. Le contrôle virologique peut permettre un projet de grossesse sans recours systématique à la PMA, avec un suivi spécialisé du couple et de la grossesse.

POUR COMPRENDRE — Oui. Le contrôle virologique peut permettre un projet de grossesse sans recours systématique à la PMA, avec un suivi spécialisé du couple et de la grossesse.

CARTE 39 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Quel est le principe de prévention mère-enfant ?

VERSO — Maintenir une charge virale maternelle contrôlée, assurer le suivi spécialisé et proposer les mesures adaptées au nouveau-né, dont la prophylaxie selon le contexte.

POUR COMPRENDRE — Maintenir une charge virale maternelle contrôlée, assurer le suivi spécialisé et proposer les mesures adaptées au nouveau-né, dont la prophylaxie selon le contexte.

CARTE 40 · Dépistage, traitement et maternité

RECTO — Allaitement et VIH : quel raisonnement retenir ?

VERSO — L'allaitement peut être discuté dans des situations sélectionnées et suivies de près ; il n'est pas automatiquement interdit. Le risque résiduel et les modalités relèvent de l'équipe spécialisée.

POUR COMPRENDRE — L'allaitement peut être discuté dans des situations sélectionnées et suivies de près ; il n'est pas automatiquement interdit. Le risque résiduel et les modalités relèvent de l'équipe spécialisée.

CARTE 41 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Que signifie « PrEP » ?

VERSO — Prophylaxie pré-exposition : utilisation préventive d'antirétroviraux chez une personne sans VIH avant certaines expositions à risque.

POUR COMPRENDRE — Prophylaxie pré-exposition : utilisation préventive d'antirétroviraux chez une personne sans VIH avant certaines expositions à risque.

CARTE 42 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Quelles modalités de prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH peut-on envisager selon les recommandations et les situations ?

VERSO — Il existe notamment des schémas oraux quotidiens ou, selon l'indication, à la demande ; des modalités injectables peuvent exister selon la disponibilité et les recommandations locales. Le choix requiert un suivi adapté.

POUR COMPRENDRE — Il existe notamment des schémas oraux quotidiens ou, selon l'indication, à la demande ; des modalités injectables peuvent exister selon la disponibilité et les recommandations locales. Le choix requiert un suivi adapté.

CARTE 43 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — La PrEP protège-t-elle des autres IST ?

VERSO — Non. Elle vise la prévention du VIH, mais ne remplace ni le préservatif, ni le dépistage et le suivi des autres IST.

POUR COMPRENDRE — Non. Elle vise la prévention du VIH, mais ne remplace ni le préservatif, ni le dépistage et le suivi des autres IST.

CARTE 44 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — PrEP et TPE : quelle différence ?

VERSO — PrEP : prévention organisée AVANT une exposition éventuelle. TPE/PEP : traitement urgent proposé APRÈS une exposition potentielle, selon l'évaluation médicale.

POUR COMPRENDRE — PrEP : prévention organisée AVANT une exposition éventuelle. TPE/PEP : traitement urgent proposé APRÈS une exposition potentielle, selon l'évaluation médicale.

CARTE 45 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Quels délais de TPE sont donnés à l'oral ?

VERSO — Le plus tôt possible après l'exposition : idéalement dans les 4 heures et au plus tard dans les 72 heures. La séance indique une durée de 28 jours.

POUR COMPRENDRE — Le plus tôt possible après l'exposition : idéalement dans les 4 heures et au plus tard dans les 72 heures. La séance indique une durée de 28 jours.

CARTE 46 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Quelles analyses accompagnent un TPE ?

VERSO — Un bilan initial, notamment VIH et hépatites selon la situation, puis des contrôles ultérieurs. La séance cite un contrôle à 6 semaines ; le calendrier exact suit le protocole.

POUR COMPRENDRE — Un bilan initial, notamment VIH et hépatites selon la situation, puis des contrôles ultérieurs. La séance cite un contrôle à 6 semaines ; le calendrier exact suit le protocole.

CARTE 47 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Que faire administrativement après un AES professionnel ?

VERSO — Ne pas oublier la déclaration d'accident du travail, en plus de la prise en charge urgente et du suivi médical prévus par le protocole.

POUR COMPRENDRE — Ne pas oublier la déclaration d'accident du travail, en plus de la prise en charge urgente et du suivi médical prévus par le protocole.

CARTE 48 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Quelles données recueillir après un rapport ou un AES à risque ?

VERSO — La date et l'heure, le type d'exposition, les protections utilisées et les informations utiles sur la source. Elles servent à orienter rapidement l'évaluation du TPE.

POUR COMPRENDRE — La date et l'heure, le type d'exposition, les protections utilisées et les informations utiles sur la source. Elles servent à orienter rapidement l'évaluation du TPE.

CARTE 49 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Quelles précautions infirmières chez une PVVIH ?

VERSO — Appliquer les précautions standard comme pour tous : pas de protection supplémentaire pour le contact ordinaire ; gants et matériel sécurisé lors d'actes exposant au sang.

POUR COMPRENDRE — Appliquer les précautions standard comme pour tous : pas de protection supplémentaire pour le contact ordinaire ; gants et matériel sécurisé lors d'actes exposant au sang.

CARTE 50 · PrEP, TPE et rôle infirmier

RECTO — Quelles dimensions composent le suivi global d'une PVVIH ?

VERSO — Éducation thérapeutique, soutien psychologique, aide sociale, médiation en santé, vaccinations et suivi régulier, avec une attitude non jugeante.

POUR COMPRENDRE — Éducation thérapeutique, soutien psychologique, aide sociale, médiation en santé, vaccinations et suivi régulier, avec une attitude non jugeante.